

Infections intra-abdominales

Méthodologie, définitions & IIA communautaires



Résumé : actualisation 2015 (SFAR/SRLF/SPILF/AFC/SFCD) de la Conférence de consensus SFAR de 2000 sur les péritonites communautaires, étendue aux infections intra-abdominales (IIA) pédiatriques et associées aux soins. **Champ :** péritonites nécessitant une prise en charge chirurgicale — **hors champ :** infections primaires des cirrhoses, infections focalisées isolées (biliaires, abcès hépatiques isolés, sigmoïdites). Règles de bon sens rappelées par les experts : éradication systématique et en urgence de la source infectieuse ; ne jamais différer l'antibiothérapie pour les prélèvements ; ne jamais prélever sur redons/drains (résultats ininterprétables) ; le spectre antibiotique doit toujours couvrir les anaérobies. **44 recommandations, toutes Accord fort.**

Définition d'une péritonite grave

Thème	Détail
Définition	Forme grave de péritonite = ≥ 2 des manifestations suivantes (en l'absence d'autre cause) :
Critères (≥ 2 requis)	Hypotension rapportée au sepsis ; lactacidémie au-dessus des valeurs normales du laboratoire ; diurèse $< 0,5$ mL/kg/h pendant > 2 h malgré un remplissage adapté ; ratio $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 250$ mmHg en l'absence de pneumopathie ; créatininémie > 2 mg/dL ($176,8 \mu\text{mol/L}$) ; bilirubinémie > 2 mg/dL ($34,2 \mu\text{mol/L}$) ; thrombopénie $< 100\,000/\text{mm}^3$.

Méthodologie — GRADE

GRADE standard : qualité des preuves en 4 catégories (Haute/Modérée/Basse/Très basse), force binaire — forte (GRADE 1+/1-) ou faible (GRADE 2+/2-) — déterminée par vote Delphi. 40 experts répartis en 6 groupes de travail ; publications retenues postérieures à 1999 (extension à 1990 si besoin). **62 recommandations initialement formalisées** → soumises à un groupe de relecture de 38 médecins → après 2 tours de cotation Delphi et amendements, 18 ont été abandonnées ou reformulées → **44 recommandations finales**, toutes à Accord fort.

Disclosure : le texte source affirme que parmi les 44 recommandations, « 10 sont fortes (Grade 1), 25 sont faibles (Grade 2) et... 9... avis d'experts ». Un comptage direct des tags individuels de ce document donne 11 Grade 1 (7×1+, 4×1-), 24 Grade 2 et 9 avis d'experts (11+24+9=44) — le total et le compte « avis d'experts » concordent, mais la répartition forte/faible annoncée par la source (10/25) diffère du tally direct (11/24).

Disclosure non résolue ici.

1+	1-	2+	2-	AE	GRADE — 1+/1- : recommandation forte ; 2+/2- : recommandation faible/optionnelle ; AE : avis d'experts (méthode GRADE non applicable). Toutes les 44 recommandations de ce texte sont à Accord fort (vote Delphi, 2 tours).
----	----	----	----	----	--

IIA communautaires — Diagnostic, contrôle de la source (R1-R8)

N°	Recommandation	Grade
R1	Il ne faut probablement pas faire d'imagerie en cas de suspicion de péritonite par perforation d'organe chez un patient grave si celle-ci retarde la procédure chirurgicale.	AE
R2	En cas de suspicion de péritonite par perforation d'ulcère gastroduodénal, l'indication opératoire peut être portée sur l'histoire clinique et la présence d'un pneumopéritoine sur un cliché d'abdomen sans préparation.	AE
R3	Il faut opérer le plus rapidement possible un patient suspect de péritonite par perforation d'organe, tout particulièrement en cas de choc septique.	1+
R4	Il ne faut probablement pas utiliser la voie laparoscopique pour l'ulcère peptique perforé en péritonite chez un patient avec plus d'1 des facteurs suivants : choc à l'admission, score ASA III-IV, symptômes > 24 h (score de Boey).	2-
R5	Il ne faut pas faire de voie d'abord laparoscopique en cas de péritonite stercorale d'origine diverticulaire (Hinchey IV) ou de péritonite généralisée.	1-
R6	En l'absence d'instabilité hémodynamique ($> 0,1$ mg/kg/min adrénaline/noradrénaline), il faut probablement discuter en pluridisciplinaire le drainage radiologique percutané en 1 ^{re} intention des abcès intra-abdominaux (sans signe de perforation) avec analyse microbiologique.	2+
R7	Il faut réaliser un contrôle du drainage par TDM en cas d'évolution défavorable.	1+
R8	Lorsque le traitement chirurgical a été jugé satisfaisant (contrôle de la source, lavage), il ne faut pas programmer systématiquement de relaparotomies.	1-



Repères : score de Boey (0-3 pts : choc à l'admission, ASA III-IV, symptômes > 24 h) — laparoscopie sûre si score 0-1, contre-indiquée si score 2-3. Relaparotomie « à la demande » (non systématique) : pas de bénéfice de survie démontré vs relaparotomie programmée, durées de séjour augmentées avec cette dernière.

IIA communautaires — Microbiologie et antibiothérapie (R9-R24)

N°	Recommandation	Grade
R9	Il faut probablement prélever les liquides péritonéaux pour identification microbienne et sensibilité aux anti-infectieux.	2+
R10	Chez les patients en choc septique et/ou immunodéprimés, il faut réaliser des hémocultures et un examen direct du liquide péritonéal à la recherche de levures.	1+
R11	Il faut établir les protocoles de traitement probabiliste sur la base de l'analyse régulière des données microbiologiques nationales/régionales de résistance.	1+
R12	Il ne faut probablement pas prendre en compte les E. coli résistants aux C3G sans signe de gravité, sauf résistance locorégionale > 10 % ou séjour en zone à forte prévalence de BMR.	2-
R13	Compte tenu de l'évolution des profils de sensibilité des bactéroïdes, il ne faut pas utiliser la clindamycine et la céfoxitine en probabiliste.	1-
R14	En l'absence de signes de gravité, il ne faut pas initier de traitement probabiliste actif sur les Candidas.	1-
R15	Dans les péritonites graves (communautaires ou associées aux soins), il faut probablement instaurer un traitement antifongique si ≥ 3 des critères suivants : défaillance hémodynamique, sexe féminin, chirurgie sus-mésocolique, antibiothérapie > 48 h.	2+
R16	Il ne faut probablement pas prendre en compte les entérocoques sans signe de gravité.	2-
R17	En 1 ^{re} intention : (1) amoxicilline/ac. clavulanique + gentamicine ; OU (2) céfotaxime/ceftriaxone + imidazolés.	2+
R18	Si allergie avérée aux β-lactamines : lévofloxacine + gentamicine + métronidazole, ou à défaut tigécycline.	AE
R19	En cas d'IIA grave, le traitement probabiliste doit être adapté sur les germes suspectés.	1+
R20	Patient grave, IIA communautaire : pipéracilline/tazobactam ± gentamicine.	2+
R21	Patient grave (communautaire ou associée aux soins), si traitement antifongique probabiliste décidé : échinocandine.	AE
R22	Après réception des analyses microbiologiques/mycologiques, il faut probablement une désescalade (spectre le plus étroit possible).	2+
R23	IIA communautaires localisées : antibiothérapie 2 à 3 jours.	2+
R24	IIA communautaires généralisées : antibiothérapie 5 à 7 jours.	2+

Infections intra-abdominales

IIA associées aux soins, algorithmes & sources



IIA associées aux soins — Diagnostic postopératoire (R25-R37)

N°	Recommandation	Grade
R25	Il faut privilégier les examens iconographiques non irradiants.	1+
R26	Il faut probablement prendre en compte <i>Pseudomonas aeruginosa</i> en cas de facteurs de gravité (défaillance viscérale, comorbidités) ou d'échec thérapeutique.	2+
R27	Il ne faut probablement pas prolonger la durée de l'antibiothérapie pédiatrique au-delà de ce qui est recommandé chez l'adulte.	2-
R28	En cas de survenue ou d'aggravation d'une dysfonction d'organe dans les jours suivant une chirurgie abdominale, il faut probablement évoquer une IIA.	2+
R29	À partir du 4 ^e -5 ^e jour post-intervention, il faut probablement discuter une reprise chirurgicale si aucune amélioration clinique/biologique.	2+
R30	L'apparition postopératoire de signes de gravité sans autre cause évidente doit faire discuter une réintervention.	2+
R31	Pour les abcès postopératoires : discuter en collégial le bénéfice-risque du drainage radiologique vs reprise chirurgicale, et probablement proposer une ponction diagnostique première à l'aiguille fine sous contrôle radiologique.	2+
R32	En cas de suspicion de péritonite postopératoire chez un patient stable, il faut probablement réaliser une TDM abdominopelvienne avec injection ($\pm$ opacification digestive à discuter).	2+
R33	En l'absence d'amélioration clinique/biologique à 4-5 j, une TDM non contributive ne permet pas d'éliminer une IIA persistante.	AE
R34	Il ne faut probablement pas utiliser de biomarqueur pour le diagnostic d'IIA persistante.	2-
R35	Ponction diagnostique première à l'aiguille fine sous contrôle radiologique pour les collections des IIA associées aux soins, en cas de doute diagnostique.	AE
R36	Il faut prélever hémocultures et liquides péritonéaux pour identification microbienne/fongique et sensibilité.	AE
R37	Il faut probablement effectuer un examen direct du liquide péritonéal à la recherche de levures.	2+

Note : la section « particularités pédiatriques » du texte source est purement narrative — littérature limitée, extrapolation des données adulte, aucune spécificité diagnostique propre à l'enfant — et ne contient aucune recommandation numérotée qui lui soit propre.

IIA associées aux soins — Antibiothérapie (R38-R44)

N°	Recommandation	Grade
R38	1 ^{er} épisode d'IIA associée aux soins : risque élevé de bactérie multirésistante si antibiothérapie dans les 3 mois précédents et/ou > 2 jours avant le 1 ^{er} épisode, et/ou délai > 5 j entre 1 ^{re} chirurgie et reprise.	1+
R39	Patients porteurs connus d'entérobactéries résistantes aux C3G, entérocoques résistants ampicilline/vancomycine, ou SARM : il faut probablement en tenir compte dans le traitement probabiliste.	2+
R40	Facteurs de risque d'entérocoque résistant à l'ampicilline (pathologie hépatobiliaire, transplanté hépatique, antibiothérapie en cours) : choisir un probabiliste actif (vancomycine, voire tigécycline).	2+
R41	Traitement antifongique probabiliste si levure à l'examen direct (échinocandines si infection grave) ; traitement systématique si culture positive à levures hors redons/draines (échinocandines si grave ou souches résistantes au fluconazole).	2+
R42	1 ^{er} épisode, sans facteur de risque de BMR : pipéracilline/tazobactam + amikacine (optionnelle si non grave). ≥ 2 des 6 critères de BMR (ou 1 seul si choc septique) : carbapénème large spectre (imipénème/méropénème/doripénème) + amikacine. 6 critères BMR : céphalosporine 3 ^e gén./fluoroquinolone < 3 mois ; portage BLSE ou <i>P. aeruginosa</i> résistant ceftazidime < 3 mois ; hospitalisation à l'étranger < 12 mois ; EHPAD médicalisé + sonde/gastrotomie ; échec d'antibiothérapie large spectre préalable ; récurrence < 15 j d'infection traitée par pipéracilline-tazobactam ≥ 3 j.	2+

Infections intra-abdominales

IIA associées aux soins, algorithmes & sources



N°	Recommandation	Grade
R43	Allergie aux β -lactamines : (1) ciprofloxacine + amikacine + métronidazole + vancomycine ; ou (2) aztréonam + amikacine + vancomycine + métronidazole ; ou (3) à défaut, tigécycline + ciprofloxacine.	AE
R44	IIA nosocomiales/postopératoires : antibiothérapie 5 à 15 jours.	AE

Algorithmes (Figures 1-3) — retranscrits depuis rendu visuel

Les 3 algorithmes du texte source (pages 97-99) sont de purs schémas boîtes/flèches sans couche texte exploitable — retranscrits ci-dessous après rendu visuel direct à 170dpi. Ils résument visuellement les recommandations R1-R44 déjà couvertes ci-dessus, sans contenu clinique nouveau.

Figure 1 — Prise en charge d'une péritonite communautaire

Étape	Conduite
Péritonite communautaire → signes de gravité ?	(critères définis dans le préambule, cf. Définition d'une péritonite grave, page 1)
Oui	→ Chirurgie (laparoscopie ou laparotomie)
Non	→ Scanner abdominal → drainage radiologique de l'abcès, ou chirurgie si besoin

Figure 2 — Traitement anti-infectieux probabiliste, péritonite communautaire

Question	Conduite
Allergie aux β-lactamines ?	Oui → lévofloxacine + métronidazole + gentamicine, OU tigécycline. Non → étape suivante.
Signes de gravité ?	Oui → pipéracilline-tazobactam + gentamicine. Non → amoxicilline-ac. clavulanique + gentamicine, OU céfotaxime/ceftriaxone + métronidazole.
Traitement antifongique ? (critères R15)	Oui → échinocandine (caspofungine, micafungine ou anidulafungine). Non → pas de traitement antifongique.

Figure 3 — Traitement anti-infectieux probabiliste, péritonite associée aux soins

Question	Conduite
Allergie aux β-lactamines ?	Oui → ciprofloxacine + métronidazole + amikacine + vancomycine, OU aztréonam + métronidazole + amikacine + vancomycine, OU tigécycline + ciprofloxacine. Non → étape suivante.
Facteurs de risque de BMR ? (critères R42)	Oui → imipénème ou méropénème $\pm$ amikacine $\pm$ vancomycine. Non → pipéracilline-tazobactam + amikacine $\pm$ vancomycine.
Traitement antifongique ? (critères R15/R41)	Oui → échinocandine (caspofungine, micafungine ou anidulafungine). Non → pas de traitement antifongique.

Déclaration d'intérêts, sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des infections intra-abdominales » — RFE conjointe SFAR/SRLF/SPILF/AFC/SFCD. Coordinateurs : P. Montravers, H. Dupont, M. Leone, J-M. Constantin, P-M. Mertes (Sfar/SRLF), P-F. Laterre, B. Misset (SRLF), J-P. Bru, R. Gauzit, A. Sotto (SPILF), C. Brigand, A. Hamy (AFC), J-J. Tuech (SFCD). Actualisation de la Conférence de consensus Sfar de 2000. 40 experts, 6 groupes de travail ; groupe de relecture de 38 médecins.

Version : Ann Fr Anesth Réanim, tome 1, n°1, février 2015.

Méthodologie : GRADE (qualité des preuves 1-4, force 1+1-/2+/2-, vote Delphi 2 tours) — voir détail en page 1.

URL source : https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/09/2_AFAR_Prise-en-charge-des-infections-intra-abdominales.pdf

Couverture : intégralité des 44 recommandations finales (texte + grade) et des 3 figures/algorithmes (retranscrits depuis rendu visuel). Hors champ, explicitement exclu par la source elle-même : infections primaires des cirrhoses, infections focalisées isolées (bilaires, abcès hépatiques isolés, sigmoïdites). La section pédiatrique du texte source est purement narrative (aucune recommandation numérotée propre) — résumée en note plutôt que reproduite in extenso faute de contenu recommandationnel propre à résumer. L'argumentaire détaillé (statistiques d'études, références bibliographiques) est volontairement condensé aux seuls seuils/schémas cliniquement actionnables — se référer au texte intégral pour le détail des preuves.

Infections intra-abdominales

IIA associées aux soins, algorithmes & sources



Avertissement — document de 2015 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des recommandations et algorithmes du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la Sfar, la SRLF, la SPILF, l'AFC ou la SFCD. Les schémas d'antibiothérapie probabiliste et les seuils de résistance bactérienne locorégionale ayant pu évoluer depuis 2015, se référer à un avis spécialisé (infectiologue, microbiologiste) et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.